

Катетеризація сечового міхура катетером Фолея

Сценарій. У хірургічному відділенні знаходиться хворий з гострою затримкою сечі яка виникла на фоні аденоми передміхурової залози. Потрібно провести катетеризацію сечового міхура катетером Фолея.

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Катетер Фолея розміром 18 F	1 шт.
2	Ємність для збору сечі	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Стерильні марлеві серветки	2 шт	20 шт
2	Гель із лідокаїном 12,5 гр	1 туба	2 туби
3	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
4	Шприц 10,0 мл	1шт	10 шт
5	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
6	Захисна медична маска	1 шт	10 шт

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Встановити контакт з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль), коректне розташування лікар-пацієнт (пацієнт-жінка: лежить на спині, ноги зігнуті в колінах, розвести стегна – позиція Валентайна; пацієнт-чоловік: лежить на спині, розведені стегна)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Підкласти під пацієнта клейонку, між ногами поставити ємність для сечі	Виконати
4	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
5	Провести візуальне та фізикальне обстеження зовнішніх статевих органів, визначити рівень наповнення сечового міхура	Сказати/Виконати
6	Для чоловіків: утримуючи статевий член у вертикальному положенні, зрушити крайню плоть і оголити головку	Виконати

	статевого члена, однією рукою зафіксувати її середнім і безіменним пальцями і розсунути зовнішній отвір сечівника; Для жінок: розвести малі статеві губи великим і вказівним пальцями однієї руки	
7	Обробити зовнішній отвір уретри марлевою кулькою з розчином нейтрального антисептика (у чоловіків: голівку статевого члена навколо зовнішнього отвору сечівника в напрямку зверху донизу - від сечовипускального каналу до периферії)	Виконати
8	Другою рукою взяти стерильним пінцетом катетер на відстані 5-7 см від його кінця, нанести стерильну змазку на дистальний кінець катетера, ввести кінець катетера в зовнішній отвір сечівника	Виконати
9	Поступово пересувати катетер глибше по сечівнику (у жінок – на 10 см; у чоловіків - на глибину 15-20 см, заново перехоплюючи катетер пінцетом кожні 3-5 см, при цьому слід рукою поступово опускати статевий член у бік мошонки. з урахуванням анатомічних особливостей) до появи сечі. Ввести в порт балона 10 мл стерильної рідини (фізіологічний розчин). З'єднати катетер з ємністю для збирання сечі. Уточнити у пацієнта його самопочуття	

Діагностика

3.1. Оцінка характеру отриманої сечі

Сказати:

«Після введення катетера отримано сечу жовтого кольору, прозору. Патологічних домішок (крові, слизу, гною) не виявлено. Це свідчить про механічну природу затримки сечі, ймовірно, внаслідок обструкції нижніх сечових шляхів при аденомі передміхурової залози.»

3.2. Оцінка кількості отриманої сечі

Сказати: «З моменту катетеризації отримано приблизно мл сечі. Це підтверджує істотне переповнення сечового міхура та ефективність відновлення відтоку після катетеризації.

Важливо контролювати діурез у динаміці для оцінки ниркової функції.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Необхідність додаткових методів дослідження (УЗД, цистоскопія)

Сказати: «Пацієнту показано проведення УЗД нирок та сечового міхура для

оцінки

залишкової сечі, структури передміхурової залози та виключення гідронефрозу. За потреби

— консультація уролога та цистоскопія після стабілізації стану.»

4.2. Призначення медикаментозної терапії (зокрема антибактеріальної)

Сказати: «З огляду на встановлений катетер та високий ризик інфекції сечовидільної

системи, рекомендовано призначення антибактеріальної терапії з урахуванням результатів аналізу сечі. Також призначаю препарати, що знижують тонус гладкої мускулатури передміхурової залози (альфа-адреноблокатори), та симптоматичну терапію (спазмолітики, знеболювальні, контроль гідратації).»

Завершення маніпуляції

Сказати й виконати: «Катетер встановлено, з'єднано з сечоприймачем.

Після надходження сечі спостерігається зменшення болю в надлобковій ділянці. Пане (прізвище), як ви почуваетесь? Чи полегшало вам після відтоку сечі?»

«Умовно утилізую використаний матеріал, знімаю рукавички, обробляю руки. Маніпуляцію завершено.»